

CAPÍTULO 3.3

Cor Pulmonale

PERFIL EUNACOM 3.01.03

Dx: Específico • Tx: Inicial • Seg: Derivar

Definición y Patogenia

El **Cor Pulmonale** se define como una **Insuficiencia Cardíaca: Generalidades** | **insuficiencia cardíaca** derecha secundaria a una hipertensión pulmonar que, a su vez, es desencadenada de manera directa por una patología o enfermedad del sistema respiratorio de base.

La cascada fisiopatológica clásica se resume de la siguiente forma:

- **Enfermedad respiratoria crónica** (ej. EPOC, Fibrosis Pulmonar, TEP Crónico).
- Generación e instauración de **hipertensión pulmonar secundaria** a hipoxia crónica.
- Sobrecarga de presión en cavidades derechas a largo plazo.
- Desarrollo final de **Insuficiencia Cardíaca: Tratamiento** | **insuficiencia cardíaca derecha** (Cor Pulmonale).

Presentación Clínica y Diagnóstico

El cuadro clínico del paciente se compone de la suma entre su historial respiratorio y los signos de claudicación ventricular derecha.

- **Síntomas y Signos:**
 - - Clínica de insuficiencia cardíaca derecha (edema de extremidades inferiores, hepatomegalia, ingurgitación yugular).
 - - Síntomas y/o antecedentes médicos propios directos de la enfermedad pulmonar basal (ej. disnea crónica por EPOC, tos productiva, antecedentes ocupacionales, etc.).
- **Estudio Diagnóstico:**
 - 1. Se sospecha inicialmente y de forma predominante a través de **la clínica** (antecedentes respiratorios previos evidentes + aparición progresiva de falla derecha).
 - 2. Confirmación a través de **Ecocardiograma**, el cual debe evidenciar y ratificar tanto la hipertensión pulmonar como la correspondiente insuficiencia cardíaca de ventrículo derecho.

Manejo y Tratamiento

El pilar fundamental para enfrentar un cuadro de Cor Pulmonale consiste en **tratar la enfermedad de base** que originó la hipertensión pulmonar, dado que esto detendrá la progresión fisiopatológica.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Recordatorio EUNACOM (Indicación de O2) En pacientes con EPOC de base que ya han evolucionado hacia un Cor Pulmonale (o a hipertensión pulmonar), estos hallazgos constituyen una **indicación absoluta de oxigenoterapia domiciliaria** crónica (cuando presentan una $PaO_2 \leq 59-60$ mmHg). Manejar la hipoxemia disminuirá la constricción vascular pulmonar.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 68 años, fumador de 40 paquetes/año, con EPOC Gold IV y oxígeno domiciliario, consulta por edema de EEII progresivo e ingurgitación yugular. PA 110/70, FC 95 lpm. ECG muestra onda P pulmonale y desviación del eje a la derecha. Ecocardiograma: dilatación de cavidades derechas con PSAP 55 mmHg."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Cor Pulmonale crónico por EPOC severa con hipertensión pulmonar secundaria. El tratamiento fundamental es optimizar la enfermedad pulmonar de base + Oxigenoterapia domiciliaria continua (> 15 h/día), que es la ÚNICA medida que reduce la mortalidad en cor pulmonale por EPOC. Los diuréticos se usan para manejo del edema.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El cor pulmonale es la afectación del ventrículo derecho por hipertensión pulmonar de origen pulmonar, excluyendo cardiopatía izquierda
- La EPOC es la causa más frecuente de cor pulmonale crónico (80-90%)
- La hipoxia alveolar crónica causa vasoconstricción pulmonar hipóxica y remodelamiento vascular
- Signos clínicos: ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema periférico y P2 acentuado
- El ecocardiograma es el examen de elección inicial; el cateterismo derecho es el gold standard
- La oxigenoterapia domiciliaria continua (>15 h/día) es la única medida que mejora sobrevida en EPOC con hipoxemia
- Los diuréticos se usan con precaución para manejar la congestión
- Los vasodilatadores pulmonares específicos solo se indican en HAP grupo 1 OMS

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (COR PULMONALE)**PREGUNTA 1**

Paciente de 68 años, fumador de 40 paquetes/año, con EPOC Gold IV, consulta por edema de extremidades inferiores, distensión abdominal y disnea en reposo. Al examen: ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema bilateral, P2 acentuado. Gases: PaO₂ 48 mmHg. ¿Cuál es la intervención que mejora la sobrevida?

- A)** Sildenafil 20 mg cada 8 horas
- B)** Digoxina 0,25 mg al día
- C)** Oxigenoterapia domiciliaria continua
- D)** Furosemida 80 mg endovenosa cada 12 horas
- E)** Enalapril 10 mg cada 12 horas

PREGUNTA 2

¿Cuál hallazgo electrocardiográfico es más sugerente de cor pulmonale crónico?

- A)** Ondas Q en cara inferior
- B)** Supradesnivel del ST en V1-V4
- C)** Onda P pulmonale con desviación del eje a derecha
- D)** Bloqueo AV de segundo grado Mobitz II
- E)** Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida

PREGUNTA 3

Respecto al cor pulmonale, ¿cuál afirmación es correcta?

- A)** Incluye la disfunción ventricular derecha por estenosis mitral
- B)** El cateterismo derecho define HTP con presión media de arteria pulmonar ≥ 20 mmHg
- C)** El tratamiento de primera línea son los calcioantagonistas
- D)** La causa más frecuente es el TEP agudo
- E)** El ventrículo izquierdo siempre está comprometido

RESUMEN: COR PULMONALE

El cor pulmonale se define como la alteración estructural y/o funcional del ventrículo derecho causada por hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades del parénquima pulmonar, la vasculatura pulmonar o la caja torácica. No se incluyen las causas de hipertensión pulmonar secundaria a cardiopatía izquierda. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica ante un paciente con enfermedad pulmonar crónica que desarrolla signos de insuficiencia cardíaca derecha: ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva, edema de extremidades inferiores y un segundo ruido pulmonar acentuado. El ecocardiograma es la herramienta diagnóstica más útil, mostrando dilatación e hipertrofia del ventrículo derecho con estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar. El cateterismo cardíaco derecho es el gold standard para confirmar hipertensión pulmonar. El tratamiento se centra en corregir la causa subyacente: oxigenoterapia crónica domiciliaria en pacientes con EPOC e hipoxemia (PaO₂ < 55 mmHg), ya que es la única medida que ha demostrado mejorar la sobrevida. Los diuréticos se utilizan con precaución para el manejo del edema. No se recomienda el uso de vasodilatadores pulmonares específicos salvo en hipertensión pulmonar del grupo 1 de la OMS.